PLANO MUNICIPAL

de Contingência Contra o Coronavírus

COVID - 19

SECRETARIA DE SAÚDE

ARROIO DO SAL - RS

AFONSO FLÁVIO ANGST

Prefeito Municipal

ADÍLSON DA SILVA VARGAS

Vice Prefeito

DIEGO FELDMANN DE VARGAS

Secretário Municipal de Saúde

NEUZA RAMON

Presidente do Conselho Municipal de Saúde- CMS

<u>Equipe responsável pela Elaboração do Plano de Contingência COVID - 19:</u>

Enfª. Coordenadora da Vigilância Epidemiológica: Marcieli dos Santos

Enfermeiras Responsáveis pelo Covid-19: Marcieli dos Santos e Alexa da Rocha

Enfª. RT do Pronto Atendimento 24 Hs: Ângela Caroline de Castilhos Flôr

Médico RT do Pronto Atendimento 24 Hs: Dr. Marlon Cenci

Coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental: Oscar Emílio Schaly

Secretário de Saúde: Diego Feldmann de Vargas

Responsável Setor Administrativo: Abigail Ribas

A capacidade de se colocar no lugar do outro é uma das funções mais importantes da inteligência. Demonstra o grau de maturidade do ser humano.”

Augusto Cury

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO..... 5

1 INTRODUÇÃO 6

2 OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA..... 8

2.1 GERAL 8

2.2 ESPECÍFICOS.....8

3 RESPONSABILIDADE MUNICIPAL NO PLANO DE CONTIGÊNCIA.....9

4 DOENÇA NÃO COMPLICADA (PACIENTE COM PERFIL DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE).....10

4.1 MANEJO CLÍNICO NA ATENÇÃO BÁSICA.....11

4.2 ACOLHIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITA E /OU CONFIRMAÇÃO DE CORONAVÍRUS NAS UNIDADES..... 13

4.3 TRATAMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITA E/ OU CONFIRMAÇÃO DIAGNOSTICADA À NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA..... 15

4.4 PROCEDIMENTOS REALIZADOS AO IDENTIFICAR CASOS SUSPEITOS 15

4.5 MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS E / OU CONFIRMADOS 16

4.6 RECOMENDA-SE O USO DOS SEGUINTES EPIs 16

4.7 ATRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS EPIs..... 17

4.8 CASOS GRAVES: ESTABILIZAR E ENCAMINHAR 18

4.9 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES 18

5 CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA A SAÚDE..... 19

6 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.....20

7 VIGILÂCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAÚDE 21

8 PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS – PLANTÃO 24 HORAS 21

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 23

APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Contingência contra o Novo Coronavírus (Covid -19) apresenta as recomendações técnicas para o desenvolvimento e a estruturação de uma vigilância que objetivando atualizações, informações e orientações aos profissionais de saúde e de outros setores quanto aos aspectos epidemiológicos e medidas de prevenção e controle do Novo Coronavírus (Covid-19), com vistas a possível ocorrência de casos confirmados da doença no município de Arroio do Sal-RS. O Plano abrange diferentes áreas que deverão atuar de forma articulada. Dentre estas estão: a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Atenção Primária à Saúde, Atenção Secundária, além das ações de comunicação e divulgação.

A Vigilância Epidemiológica fará o monitoramento e avaliação de todos os casos suspeitos notificados do Novo Coronavírus (Covid-19) juntamente com a equipe de apoio, para que as medidas de prevenção e controle possam ser desencadeadas. Devido ao crescente aumento de pessoas suscetíveis ao Novo Coronavírus (Covid-19), a circulação do vírus em várias partes do mundo e importação de casos suspeitos para o Brasil além dos casos comunitários, ou seja, aqueles casos que não se sabe a fonte assim surge uma maior probabilidade de propagação viral. Desta forma, a Secretaria da Saúde de Arroio do Sal, elabora um Plano de Contingência no sentido de controlar a entrada e disseminação do vírus, incluindo estratégias de Vigilância Epidemiológica, Sanitária entre outras.

1 INTRODUÇÃO

O presente documento foi elaborado para subsidiar no planejamento e organização dos serviços para resposta rápida e oportuna, frente a possível ocorrência de surto por Infecção Humana pelo novo Coronavírus (Covid-19). Em 31 de dezembro de 2019, o Escritório da OMS na China foi informado de casos de pneumonia de etiologia desconhecida (causa desconhecida) detectada na cidade de Wuhan, na China. As autoridades chinesas em 7 de janeiro de 2020 anunciaram que o vírus causador do surto era uma nova cepa dos coronavírus.

Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV). Todos os coronavírus que afetam humanos tem origem animal.

O novo coronavírus foi classificado como Covid-19, trata-se de uma cepa que não foi previamente identificada em humanos, fato que tem dificultado a descrição detalhada do espectro clinico da infecção, bem como o padrão de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade.

A princípio os pacientes identificados com a doença respiratória aguda causada pelo Covid-19 na China tiveram contato com animais vivos, em um mercado de frutos do mar e animais vivos da cidade de Wuhan, sugerindo a disseminação da doença de animais para pessoa, porém um número crescente de pacientes supostamente não se expôs a este mercado de animais, indicando assim a disseminação de pessoa para pessoa.

O modo de transmissão pode ter ocorrido principalmente por meio de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. O período médio de incubação é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 14 dias. Dados preliminares da doença respiratória aguda (Covid-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, no entanto até o momento as informações são insuficientes para determinar o período que uma pessoa infectada pode transmitir o vírus.

As manifestações clínicas da doença respiratória aguda (Covid-19) podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa, de acordo com os dados mais atuais os sinais e sintomas clínicos são principalmente respiratórios, com apresentação de febre, tosse e dificuldade para respirar. As complicações incluíram síndrome respiratória aguda grave-SRAG, lesão cardíaca aguda e infecção secundária e óbito.

O diagnóstico pode ser clínico, observando os quadros de síndrome gripal, com investigação clínico - epidemiológica, exame físico e laboratorial específico para Coronavírus com as técnicas de detecção do genoma viral (RT-PCR) em tempo real e sequenciamento parcial ou total. O diagnóstico diferencial deve ser realizado para influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros.

Até o momento o tratamento é inespecífico, com adoção de medidas de suporte, levando em consideração o diagnóstico diferencial para adequar o manejo clínico. Recomenda-se medidas de precauções padrões e isolamento de casos suspeitos para controle da infecção.

2 OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

2.1 Geral

Ações de prevenção e controle da doença de modo oportuno e eficaz diante a identificação de casos suspeitos.

Descrever o padrão epidemiológico de ocorrência do Coronavírus (Covid -19) entre os residentes do município de Arroio do Sal - RS.

2.2 Específicos

- Descrever estratégias de identificação oportuna de casos suspeitos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde (MS), no sentido de controlar e reduzir a disseminação do Covid-19 no município;

- Definir responsabilidades e prioridades na esfera municipal, assim como também organizar o fluxograma de resposta às emergências em saúde pública;

- Orientar e recomendar medidas de controle e prevenção da doença, de forma ativa, imediata e oportuna;

- Definir fluxos de referência para atendimento aos casos suspeitos com sintomas respiratórios leves e graves.

- Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços, visando a integralidade das ações para enfrentamento da doença;

- Reforçar ações de articulação intersetorial em todas as esferas de Gestão;

- Orientar a utilização das medidas de prevenção e controle disponível.

3 RESPONSABILIDADE MUNICIPAL NO PLANO DE CONTINGÊNCIA.

- Orientar o funcionamento da sala de situação no município após detecção da circulação viral do Covid-19 em território municipal, acompanhando indicadores epidemiológicos, operacionais e assistenciais;

- Apoiar na intensificação e no monitoramento das ações dos procedimentos seguros para coleta de amostras;

- Apoiar a intensificação da Vigilância dos Vírus Respiratórios frente à investigação de casos suspeitos e confirmados de Covid-19 na esfera municipal;

- Assessorar as Estratégias Saúde da Família (ESF) no acompanhamento das ações realizadas pelo município de Arroio do Sal - RS;

- Articular com as Estratégias Saúde da Família (ESF) para a viabilização das ações a serem desenvolvidas, em tempo oportuno.

- Encaminhar às ESF os ofícios e notas informativas orientando as ações de prevenção e controle para disseminação do vírus;

- Consolidar as informações epidemiológicas e laboratoriais para subsidiar a tomada de decisão, por meio de boletins e notas técnicas;

- Capacitar os profissionais para realização dos procedimentos seguros para coleta de amostras;

- Sensibilizar os profissionais para a notificação, investigação e realização das ações de prevenção e controle do Covid-19, de forma oportuna;

4. Doença não complicada (Pacientes com perfil de atendimento das Unidades Básicas de Saúde)

Agente Etiológico: Pertencente à família *Coronaviridae*, gênero *Coronavírus,* subdividido em três grupos principais, com base em propriedades genéticas e sorológicas.

Período de Incubação: Estima-se que o período de incubação seja de 2 a 14 dias.

Modo de transmissão: A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como:

- Gotículas de saliva;
- Espirro;
- Tosse;
- Secreção nasofaríngea;
- Contato com pessoa doente;
- Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Suscetibilidade: Existe suscetibilidade geral em todos os grupos, com idosos e pessoas com doenças preexistentes com maior probabilidade de se tornarem casos graves.

Manifestações Clínicas: Os sinais e sintomas clínicos do Novo Coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Porém, podem causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.

Os principais são sintomas são: febre, tosse e dificuldade para respirar.

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos do Covid-19 deve se dar em consulta médica da seguinte forma:

A. Casos leves.

Aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da APS/ESF devido à menor gravidade do caso; e

B. Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, necessitam de estabilização na APS/ESF e encaminhamento ao Hospital Nossa Senhora Navegantes.

4.1 Manejo Clínico na Atenção Básica

Seguindo as diretrizes do MS e da OMS, para o manejo clínico da infecção respiratória aguda, quando houver suspeita de infecção por Covid-19, orienta-se que sejam adotadas medidas gerais de prevenção, com o intuito de redução do risco de adquirir e/ou transmitir doenças respiratórias, tais como:

- Realizar frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alimentos;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, e sempre higienizar com água e sabão ou álcool em gel na falta destes;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
- Manter os ambientes bem ventilados;

Cuidados com o paciente

1. Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados no acolhimento na Atenção Primária até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.

2. Encaminhar o caso suspeito para o isolamento que será disponibilizado dentro de cada Unidade Básica de Saúde.

3. Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI (preferencial máscara N95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerossolização (P. ex: entubação, aspiração traqueal, ventilação não invasiva etc); eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental);

4. Realizar higiene de mãos.

5. Alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus podem não necessitar de hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Porém, é necessário avaliar cada caso, levando-se em consideração se o ambiente domiciliar é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde.

6. Casos suspeitos ou confirmados para 2019-nCoV que não necessitem de hospitalização e o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax, hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a depender da avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão receber orientações de controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis complicações, procurar o serviço de saúde mais próximo a residência.

7. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária à Saúde e instituídas as medidas de precaução domiciliar.

8. Os casos graves devem ser encaminhados ao Hospital Nossa Senhora dos Navegantes em Torres - RS para isolamento e tratamento.

4.2 Acolhimento aos pacientes com suspeita e/ou confirmação de coronavírus nas Unidades Básicas de Saúde:

Sala de Isolamento nas Unidades Básicas de Saúde:

Em todas as Unidades de Saúde do município de Arroio do Sal, o atendimento dos casos suspeitos e/ou confirmados serão realizados dentro de uma sala específica de isolamento evitando a propagação do coronavírus.

Notificação:

A **notificação imediata** deve ser realizada no primeiro atendimento o mais rápido possível, **a partir do conhecimento de CASO QUE SE ENQUADRE NA DEFINIÇÃO DE SUSPEITO.**

Os casos suspeitos de infecção por 2019-nCoV devem ser comunicados imediatamente pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, ao Setor Municipal de Vigilância Epidemiológica no telefone (51) 3687-3667 ou ainda pelo e- mail: epidemiologia@arroiodosal.rs.gov.br

Após a notificação do caso suspeito, deverá ser realizado busca ativa de contatos próximos (familiares, colegas de trabalho, entre outros, conforme investigação), devendo estes ser orientados sob a possibilidade de manifestação de sintomas e da necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio, mantendo distância dos demais familiares, além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até que seja descartada a suspeita. Os indivíduos próximos que manifestarem sintomas devem ser orientados a procurar **imediatamente** o serviço de saúde. O monitoramento dos casos suspeitos e dos contactantes deverá ser por 14 dias.

Contato Próximo: Estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por Novo Coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de EPI. O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de

assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.

Laboratório:

A coleta laboratorial deve ser realizada para os casos suspeitos de coronavírus por meio da coleta combinada de *swab* (nasal/oral),de todos os casos que se enquadrem nos critérios de suspeição clínica e ou epidemiológico

Orientações para coleta, acondicionamento e transporte:

Em serviços de saúde PÚBLICOS, é necessária a coleta de 1 (uma) amostra respiratória.

A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer caso suspeito de 2019-nCoV. A coleta deverá ser realizada, preferencial, até o 3º dia, podendo ser estendida até o 7º dia, por profissional de saúde devidamente treinado e em uso de equipamento de proteção individual (EPI) apropriados: avental, óculos de proteção, touca, luvas e máscara (N95 ou PFF2).

Coleta de SWAB combinado (nasal/oral)

Introduzir o swab de rayon na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando para cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45° em relação ao lábio superior. Após a introdução, esfregar o swab com movimentos circulares delicadas, pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção a orelha do paciente).

Remover o swab do nariz do paciente e introduzi-lo imediatamente no meio de transporte (MEM).

Colher swab nas duas narinas (uma em cada narina).

Colher o terceiro swab na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua. Após a coleta, inserir os três swabs em um mesmo frasco contendo o meio de transporte viral. Rotular a amostra no tubo de transporte MEM com o nome completo do paciente.

Deverão ser colhidos 3 swabs de rayon sendo 1 nasofaringe direito, 1 nasofaringe esquerdo e 1 orofaringe para cada meio de transporte (MEM).

As amostras serão processadas para vírus respiratórios no LACEN e encaminhadas ao Laboratório de referência nacional para ser processada para 2019-nCoV.

As amostras coletadas devem ser mantidas sob refrigeração (4 a 8ºC) e devem ser encaminhadas ao Laboratório de referencia LACEM em Porto Alegre, em caixa térmica com gelo reciclável e acompanhadas da ficha epidemiológica devidamente preenchida.

As amostras deverão chegar ao Laboratório LACEM de referência até 72 horas após a coleta.

4.3 Tratamento aos pacientes com suspeita e/ou confirmação diagnóstica à nível de Atenção Básica:

Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-térmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas.

4.4 Procedimentos realizados ao identificar casos suspeitos:

Pacientes que apresentem sintomas leves, faz-se necessário o isolamento domiciliar, seguindo as orientações descritas abaixo:

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL		
Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes.		
Isolamento de contato do paciente	**Precauções do cuidador**	**Precauções gerais**
• Permanecer em quarto isolado, bem ventilado e sem divisão com outros membros da família; • Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. Dormir em cama separada (exceção: mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene, como a lavagem constante de mãos); • Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com compartilhamento (como cozinha, banheiro etc.) devem estar bem ventilados; • Utilização de máscara cirúrgica. Caso o paciente não tolere ficar por muito tempo, realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência; trocar máscara cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danificada; • Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar obrigatoriamente máscara; • Sem visitas ao doente; • O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com máscara e evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que possível.	• O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do paciente. Caso a máscara fique úmida ou com secreções, deve ser trocada imediatamente. Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuidador deve lavar as mãos; • Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois do contato com o paciente, antes/depois de ir ao banheiro, antes/depois de cozinhar e comer ou toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos estiverem secas e água e sabão quando as mãos parecerem oleosas ou sujas; • Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida.	• Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que ficar úmida; • Todos os moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz quando forem tossir ou espirrar, seja com as mãos ou máscaras. Lavar as mãos e jogar as máscaras após o uso; • Evitar o contato com as secreções do paciente; quando for descartar o lixo do paciente, utilizar luvas descartáveis; • Limpar frequentemente (mais de uma vez por dia) as superfícies que são frequentemente tocadas com solução contendo alvejante (1 parte de alvejante para 99 partes de água); faça o mesmo para banheiros e toaletes; • Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão comum e água entre 60-90ºC, deixe secar.

: WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019

4.5 Monitoramento dos casos suspeitos e/ou confirmados:

A equipe de Apoio manterá o contato com o caso suspeito e/ou confirmado, por meio de telefone, buscando monitorar os sinais da doença para acompanhar a evolução do quadro clínico.

Recomendações preventivas envolvendo todos os profissionais das Unidades Básicas de Saúde.

4.6 Recomenda-se o uso dos seguintes EPIs:

· Máscara Cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;

· Máscara Respirador N95, preferencial nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerolização.

· Protetor Ocular (óculos de segurança) quando houver risco de exposição do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções;

· Os óculos, após o uso, devem sofrer processo de limpeza com água e sabão/ detergente e desinfecção. Sugere-se a desinfecção por fricção com álcool 70% após cada uso ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante;

· Luvas de Procedimento: devem ser utilizadas, conforme recomendada nas precauções padrão, quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados;

· Capote/Avental Impermeável Descartável.

4.7. Atribuições dos serviços de saúde em relação aos EPI

Compete aos serviços de saúde em relação ao EPI:

Garantir Epi`s necessários para os profissionais que atenderão casos suspeitos ou confirmados; Garantir Epi`s de acordo com a normatização do Lacen para a realização do SWAB e em quantidade necessaria para atendimento suposto surto do Covid-19;

Fornecer os EPI, gratuitamente, aos trabalhadores de acordo com os riscos a que estão expostos; orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação;

Substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica.

Atribuições dos trabalhadores em relação aos EPI

Compete aos trabalhadores em relação ao EPI:

Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;

Responsabilizar-se pela guarda e conservação;

Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como por exemplo o uso de máscaras molhadas ou amassadas.

4.8. Casos Graves: Estabilizar e Encaminhar

Casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de Atenção à Saúde de Arroio do Sal - RS.

O encaminhamento será de responsabilidade da equipe do Centro Triagem do Covid-19 onde ocorreu a classificação do caso. Deve-se articular na rede local de saúde a necessidade de recepcionamento priorizado desse cidadão, garantindo transporte sanitário adequado (Ambulancia local ou SAMU).

Medidas de segurança com os pacientes suspeitos e/ou diagnosticados com coronavírus na utilização de transporte das Unidades Básicas de Saúde:

O transporte da Unidade Básica de Saúde deverá ser utilizado apenas para casos suspeitos e /ou confirmados de baixa gravidade.

4.9 Seguindo as recomendações:

1. Limitar o número de pessoas dentro do veículo ao estritamente necessário;

2. Notificar o setor que receberá o paciente e o setor de transporte interno para providenciar as medidas cabíveis de desinfecção do transporte utilizado;

3. Durante o transporte o paciente deve utilizar a máscara cirúrgica;

4. Manter o transporte arejado, com janelas abertas e ar-condicionado desligado;

OBS:

A desinfecção e limpeza interna de todas as partes do veículo, após a realização do transporte, pode ser feita com álcool a 70% e hipoclorito de sódio indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos.

5. Controle de Infecção Relacionados à Assistência à Saúde

A desinfecção de superfícies das Unidades de Saúde deve ser realizada após a sua limpeza. Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois, alguns fenóis e alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies do isolamento com detergente neutro seguida da desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante padronizado pelo serviço de saúde, desde que seja regularizado junto à Anvisa.

No caso da superfície apresentar matéria orgânica visível deve-se inicialmente proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido absorvente e posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta.

Ressalta-se a necessidade da adoção das medidas de precaução para estes procedimentos.

6. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A vigilância epidemiológica (VE) Covid-19 tem como objetivo geral orientar o Sistema Municipal de Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de Atenção à Saúde para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo Novo Coronavírus investigar e acompanhar os riscos de transmissão sustentada no território municipal e realização de campanha de educação em saúde com os colaboradores e profissionais do setor privado sobre os usos de EPI's corretamente além de procedimentos de higienização para prevenção ao coronavírus;

6.1 Objetivos específicos:

Atualizar periodicamente o cenário epidemiológico com base nas evidências técnicas e científicas nacionais e/ou internacionais;

Descrever o acometimento da doença segundo variáveis de tempo, pessoa e lugar;

Prover análises epidemiológicas identificando grupos de risco;

Subsidiar a gestão local na tomada de decisões baseadas em evidências;

Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos;

Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;

Acompanhar a tendência da morbimortalidade associadas à doença; identificar outros vírus respiratórios circulantes; produzir e disseminar informações epidemiológicas.

7 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL EM SAÚDE

O setor de Vigilância Sanitária e Ambiental em Saúde tem trabalhado nas orientações e fiscalizações nos estabelecimento comerciais imprescindíveis que estão funcionando durante o período de quarentena.

Através dos fiscais estão sendo vistoriados questões relacionadas no uso de EPI´S por parte dos funcionários e colaboradores nos estabelecimentos, bem como as exigências constantes nos decretos Estaduais e Municipais de políticas de enfrentamento do Coronavírus (COVID-19).

Os Agentes de Combate a Endemias, fazem suporte ao setor de vigilância epidemiológica em demandas solicitadas pela enfermeira coordenadora do setor.

8 PLANO DE CONTINGÊNCIA CORONAVÍRUS – PLANTÃO 24 HS

Orientações gerais:

Identificação de KIT's (EPI's) para uso de pacientes em isolamento com suspeita de Corona Virus;

Elaboração de orientações para isolamento domiciliar conforme recomendações MS;

Monitoramento dos processos de higienização da equipe de limpeza da Unidade;

Uso de enfermaria de isolamento para pacientes com suspeita de corona vírus em situação de internação hospitalar. (Será restrio apenas para uso em isolamento).

Realização de campanha de educação em saúde com os colaboradores sobre os usos de EPI's corretamente além de procedimentos de higienização para prevenção ao Coronavírus;

Fornecimento de EPI's conforme recomendação;

Orientação sobre uso adequado de EPI's;

Definição de sinais e sintomas para identificação de casos suspeitos junto à equipe médica;

Definição de fluxo de Pacientes com coronavírus;

Capacitação e treinamento para equipe de coleta de exames laboratoriais para coleta de pacientes com suspeita de coronavírus;

Exibição de vídeo educativo e distribuição de folders explicativos na sala de espera para pacientes e acompanhantes;

Realização de atendimentos para pacientes com sintomas gripais:

Todos os pacientes que procurarem atendimento com sintomas gripais deverão se dirigir ao Centro de Triagem para o Coronavírus, que fica localizado no mesmo local do pronto atendimento 24 horas, porém com porta de entrada específica para esses casos. Esta estrutura é uma extensão da Atenção Básica, utilizando o CNES 7262507, onde terá uma equipe somente para atendimento desses casos, com o intuito de acolher os pacientes com sintomas para que não seja necessária a entrada pela porta do ponto atendimeto 24 horas, evitando exposição desnecessária.

As remoções dos casos mais graves serão realizadas pelo município, até a referência que é o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.

Também temos o SAMU que dará o suporte para atendimento nos domicílios.

O acompanhamento domiciliar será realizado por uma equipe de suporte e pela Vigilância Epidemiológica

9 Considerações finais:

As providências descritas nesse plano poderão ser alteradas a qualquer momento, seguindo orientações institucionais ou ajustes nas medidas implementadas em função da evolução desta pandemia. Todos os servidores terão acesso às medidas de segurança descritas acima.